

★ PNEUMONIA – (تبسيط كامل) الالتهاب الرئوي

1) Definition – التعريف

Pneumonia is inflammation of the lung tissue caused by bacteria, viruses, fungi, or mycobacteria.

الالتهاب الرئوي هو التهاب يحدث في نسيج الرئة بسبب بكتيريا أو فيروسات أو فطريات أو الميكوبكتيريا.

2) Classification – التصنيف

Community-Acquired Pneumonia (CAP)

Happens outside the hospital or within the first 48 hours of admission.

يحدث خارج المستشفى أو خلال أول ٤٨ ساعة من دخول المريض.

Hospital-Acquired Pneumonia (HAP)

Occurs after 48 hours of being admitted; includes ventilator-associated pneumonia.

يحدث بعد مرور ٤٨ ساعة في المستشفى، ويشمل الالتهاب الناتج عن أجهزة التنفس الصناعي.

Immunocompromised Host Pneumonia

Happens in people with weak immune systems.

يحدث في الأشخاص الذين يعانون من ضعف في المناعة.

Aspiration Pneumonia

Happens when food or liquid enters the lungs by mistake.

يحدث عندما يدخل الطعام أو السوائل إلى الرئة بالخطأ بدل ما تروح للمعدة.

3) Causes / Risk Factors – عوامل الخطر

Conditions like smoking, COPD, cancer, and old age increase the risk.

والسرطان وكبر السن تزيد من خطر الإصابة COPD أشياء مثل التدخين ومرض.

Immobility and poor swallowing also increase the risk.

قلة الحركة وضعف البلع يزيدان أيضًا من احتمال حدوث المرض.

Having NG/OG tubes or being NPO increases risk of aspiration.

وجود أنابيب تغذية أو الامتناع عن الأكل يزيد خطر دخول السوائل للرئة.

Supine position, anesthesia, alcohol, and weak immunity also contribute.

النوم على الظهر، البنج، الكحول، وضعف المناعة تزيد من احتمالية الإصابة.

4) Pathophysiology – آلية المرض

The alveoli fill with inflammatory fluid which reduces oxygen exchange.

الحويصلات الهوائية تمتلئ بسائل التهابي مما يقلل تبادل الأكسجين.

This leads to poor ventilation and sometimes bronchospasm.

وهذا يسبب ضعفًا في التهوية وقد يؤدي لتشنج الشعب الهوائية.

5) Clinical Manifestations – الأعراض

Fatigue, fast breathing, cough, and thick (purulent) sputum.

إجهاد، تنفس سريع، سعال، وبلغم صديدي.

Elderly may show confusion, dehydration, or unusual behavior.

كبار السن قد يظهر عليهم ارتباك أو جفاف أو سلوك غير طبيعي.

6) Assessment & Diagnosis – التقييم والتشخيص

Physical examination and checking symptoms.

فحص بدني وملاحظة الأعراض.

Chest X-ray, sputum test, and blood culture.

أشعة صدر، تحليل بلغم، وزراعة دم.

7) Prevention – الوقاية

Vaccination for high-risk groups like elderly and immunocompromised.

التطعيم للمسنين والذين يعانون من ضعف المناعة.

Encourage coughing and clearing secretions.

تشجيع المريض على الكحة وطرد الإفرازات.

Suctioning and chest physiotherapy if needed.

الشفط والعلاج التنفسي عند الحاجة.

Reposition the patient frequently.

تغيير وضع المريض باستمرار.

Elevate the head of bed at least 30°.

رفع رأس السرير ٣٠ درجة أو أكثر.

Good oral hygiene and stop smoking.

نظافة الفم الجيدة والإقلاع عن التدخين.

8) Medical Treatment – العلاج الطبي

Antibiotics if there is bacterial infection.

مضادات حيوية عند وجود عدوى بكتيرية.

Hydration to replace fluid loss.

تعويض السوائل بسبب الجفاف.

Antipyretics for fever.

أدوية خافضة للحرارة.

Warm inhalation helps reduce irritation.

الاستنشاق الدافئ يساعد على تهدئة الشعب.

Oxygen if hypoxia occurs.

أكسجين عند وجود نقص في الأكسجين.

9) Nursing Process – دور التمريض

Nursing Diagnoses – تشخيصات التمريض

Ineffective airway clearance due to secretions.

عدم فعالية تطهير مجرى الهواء بسبب الإفرازات.

Activity intolerance due to poor breathing.

عدم تحمل النشاط بسبب صعوبة التنفس.

Risk of dehydration due to fever and rapid breathing.

خطر الجفاف بسبب الحمى والتنفس السريع.

Lack of knowledge about treatment.

نقص معرفة المريض بخطة العلاج.

Nursing Interventions – التدخلات التمريضية

Encourage deep breathing and coughing.

تشجيع التنفس العميق والكحة.

Use chest physiotherapy and correct positioning.

استخدام العلاج التنفسي ووضع الجسم الصحيحة.

Increase fluids (unless contraindicated).

زيادة شرب السوائل إذا ما كان هناك مانع.

Educate patient and family about disease and care plan.

توعية المريض وأسرته عن المرض وخطة العلاج.

Expected Outcomes – النتائج المتوقعة

Better airway clearance.

تحسن تطهير مجرى الهواء.

More energy and less fatigue.

زيادة النشاط وتقليل الإجهاد.

Adequate hydration.

ترطيب جيد للجسم.

No complications.

عدم حدوث مضاعفات.

★ TUBERCULOSIS (TB) – الدرن (تبسيط كامل)

1) Definition – التعريف

TB is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis.

الدرن مرض معدٍ تسببه بكتيريا الميكوبكتيريوم تيوبركولوزيس.

Affects mainly the lungs but can spread to other organs.

يؤثر أساسًا على الرئتين ويمكن أن ينتشر لأعضاء أخرى.

Spread through airborne droplets from coughing.

ينتقل عبر الرذاذ المتطاير أثناء السعال.

2) Stages – المراحل

Early infection → Primary TB → Latent TB → Secondary TB.

عدوى مبكرة → درن أولي → درن كامن → درن ثانوي.

3) Manifestations – الأعراض

Cough for more than 3 weeks, weight loss, fever, night sweats.

كحة لأكثر من 3 أسابيع، فقدان وزن، حرارة، عرق ليلي.

Chest pain, fatigue, hemoptysis, dyspnea.

ألم صدر، إرهاق، إرهاب، بصب دم، ضيق نفس.

4) Diagnosis – التشخيص

History & physical exam.

تاريخ مرضي وفحص بدني.

Sputum culture and chest X-ray.

زراعة بلغم وأشعة صدر.

Mantoux test: 0.1 ml PPD → read after 48–72 hours; positive if ≥ 10 mm induration.

اختبار مانتو: حقن 0.1 مل تحت الجلد ويُقرأ بعد 48–72 ساعة؛ يعتبر إيجابي إذا كان التورم ≤ 10 مم.

5) Treatment – العلاج

Treatment is done using the **RIPE regimen**.

RIPE العلاج يتم باستخدام نظام.

First 2 months: Rifampicin + Isoniazid + Pyrazinamide + Ethambutol.

أول شهرين: ريفامبيسين + أيزونيايد + بيرازيناميد + إيثامبوتول.

Next 4–6 months: Rifampicin + Isoniazid only.

بعدها 4–6 شهور: ريفامبيسين + أيزونيايد فقط.

Some patients may need extra antibiotics (amikacin...etc).

بعض المرضى يحتاجون مضادات إضافية مثل أميكاسين.

6) Nursing Interventions – تدخلات التمريض

Give TB medications on time.

إعطاء أدوية الدرن في مواعيدها.

Apply respiratory isolation and proper ventilation.

عزل المريض تنفسيًا مع تهوية جيدة للغرفة.

Monitor breathing pattern and symptoms.

متابعة التنفس والأعراض.

Encourage smoking cessation.

تشجيع المريض على الإقلاع عن التدخين.

Provide high-protein and high-vitamin diet.

توفير غذاء عالي البروتين والفيتامينات.

Collect 3 early-morning sputum samples.

جمع 3 عينات بلغم صباحية.

Increase fluid intake to loosen secretions.

زيادة السوائل لتخفيف الإفرازات.

Perform chest physiotherapy frequently.

عمل علاج تنفسي باستمرار.

7) Complications – المضاعفات

Pleurisy, meningitis, bone infection, GI or GU infection.

التهاب الغشاء المحيط بالرئة، التهاب السحايا، عدوى في العظام، وعدوى جهاز هضمي أو بولي.

Bronchiectasis.

تمدد الشعب الهوائية.